



FAQ Operacional - Pré-operatório e Segurança

Documento educacional baseado em referências reconhecidas de segurança do paciente. Não representa protocolo de uma instituição específica.

1. O paciente chegou sem o termo exigido. O que fazer?

Confirmar a pendência, comunicar a equipe responsável e seguir o fluxo institucional antes do procedimento. Não presumir consentimento nem preencher informação em nome de outra pessoa.

2. O paciente diz que já assinou o termo, mas ele não aparece no sistema.

Verificar os locais institucionais de armazenamento e comunicar o setor/profissional responsável. Registrar a pendência e as providências adotadas. Uma afirmação verbal de assinatura prévia não substitui automaticamente o documento exigido.

3. Há divergência entre o lado informado pelo paciente e a documentação.

Não prosseguir com o fluxo do procedimento até que a divergência seja esclarecida pela equipe responsável. A segurança cirúrgica exige confirmação do paciente, procedimento e local corretos.

4. O paciente relata alergia que não consta no cadastro.

Registrar a informação conforme rotina, incluindo a reação quando conhecida, sinalizar conforme protocolo e comunicar a equipe antes de medicamentos ou exposição potencial ao agente.

5. O paciente quebrou o jejum.

Registrar o que foi ingerido e o horário, quando possível, e comunicar a equipe anestésica/cirúrgica. A decisão de manter, adiar ou modificar o procedimento depende da avaliação profissional.

6. O sistema está exibindo dados de outro paciente.

Interromper o registro naquele prontuário/tela, confirmar a identificação correta e acionar o suporte ou fluxo institucional. Não copiar, alterar ou validar dados pertencentes a outro paciente.

7. Um campo obrigatório do sistema está indisponível.

Não inventar informação para concluir a etapa. Registrar por meio do fluxo alternativo autorizado, quando existente, e comunicar o problema ao suporte/setor responsável.

8. O paciente se recusa a assinar.

Respeitar a manifestação, comunicar o profissional responsável para esclarecimentos e registrar objetivamente a recusa e a conduta. Não coagir o paciente nem assinar em seu lugar.

9. Quando avaliar risco de queda?

A avaliação deve ocorrer na admissão e ser reavaliada conforme protocolo e mudanças da condição clínica. As medidas preventivas devem ser compatíveis com o risco identificado.

10. O agente MedFlow AI pode decidir uma conduta clínica?

Não. O MedFlow AI deve recuperar orientações documentais e indicar quando a situação exige avaliação da equipe responsável. Ele não substitui julgamento clínico, prescrição, avaliação anestésica ou protocolo institucional.

Referências-base

- Ministério da Saúde / ANVISA / Fiocruz - Protocolos Básicos de Segurança do Paciente: identificação do paciente, cirurgia segura, prevenção de quedas e segurança no uso de medicamentos.
- RDC ANVISA nº 36/2013 - ações para segurança do paciente em serviços de saúde.
- Conselho Federal de Medicina - Resolução CFM nº 1.638/2002 (prontuário médico) e Recomendação CFM nº 1/2016 (consentimento livre e esclarecido).
- American Society of Anesthesiologists - Practice Guidelines for Preoperative Fasting (referência internacional para jejum em procedimentos eletivos: aplicação depende da avaliação anestésica e do protocolo institucional).

Nota de uso: material preparado para projeto acadêmico de RAG. Na assistência real, prevalecem legislação vigente, protocolos institucionais e avaliação dos profissionais responsáveis.